🔗 **SISTEMA REDE** 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

Desenvolvido por autistas, para o MUNDO.
Porque quem entende melhor os desafios e as vitórias da jornada é quem caminha diariamente por ela.

Proposta Técnica
Protocolo URSULA + Sistema REDE

1. Visão Geral do Projeto

O Sistema REDE é um protótipo inteligente de monitoramento, análise e integração de dados voltado ao autismo, criado por autistas e para autistas.

Seu propósito é transformar dados em qualidade de vida, gerando informações práticas e personalizadas que orientam decisões terapêuticas, pedagógicas e familiares.

Mais do que uma ferramenta tecnológica, o REDE é um ecossistema de cuidado, inclusão e inovação social, que integra ciência de dados, inteligência emocional e tecnologia assistiva para apoiar o desenvolvimento e a autonomia de pessoas autistas.

2. Estrutura Modular

O Sistema REDE é composto por três módulos independentes e integráveis, que juntos oferecem uma visão completa do comportamento, rotina e bem-estar da pessoa autista:

🏠 **Módulo MAD — Monitoramento de Atividades Domésticas**

lojinhadosautistas@gmail.com | @lojinhadosautistas

🔗 SISTEMA REDE 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

- Registro e análise de rotinas diárias em ambiente familiar.
- Permite identificar padrões de comportamento, hábitos e momentos de sobrecarga sensorial.
- Apoia familiares e terapeutas no acompanhamento do progresso individual e na adaptação de rotinas.

🌎 **Módulo MAP — Monitoramento de Atividades Programáticas**

- Voltado a ambientes externos: escola, trabalho, lazer e comunidade.
- Acompanha indicadores de desempenho, adaptação social e respostas a estímulos externos.

⚠️ **Módulo RAI — Rastreio de Ações Indesejadas**

- Sistema de alerta e rastreio de padrões comportamentais críticos.
- Identifica antecipadamente situações de crise, ansiedade extrema ou sobrecarga emocional.

3. Integração e Inteligência Analítica

Os três módulos se comunicam por meio de um núcleo central de análise de dados, que:

- Consolida informações clínicas, comportamentais e contextuais.
- Utiliza algoritmos de interpretação semântica e correlação comportamental.

Os Relatórios técnicos são o principal produto de saída do sistema: um documento vivo, dinâmico e 100% personalizado que orienta o desenvolvimento contínuo com uma visão multidisciplinar.

🔗 SISTEMA REDE 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

4. Apresentação do “Protocolo URSULA”

O **Protocolo Ursula** nasce da necessidade de responder a um tipo específico de problemática humana que não é adequadamente resolvida por sistemas de análise, diagnóstico ou intervenção direta.

Trata-se de conflitos e sofrimentos que emergem **entre sujeitos**, e não apenas dentro deles, marcados por falhas de comunicação, diferenças simbólicas, assimetrias culturais e impossibilidades de tradução de sentidos.

Este protocolo é inspirado nas boas práticas metodológicas do Sistema REDE — especialmente nas modelagens representadas pelos agentes de inteligência artificial ‘Lucas’ e ‘Dra Nise’ — sem, contudo, integrar-se estruturalmente a esses agentes neste momento.

O **Protocolo Ursula** é, portanto, **autônomo**.

5. Natureza do Problema que o Protocolo Endereça

O **Protocolo Ursula** foi concebido para lidar com situações em que:

- Há desejo de comunicação, mas ausência de compreensão;
- Há vínculo, mas há ruído persistente;
- Há sofrimento relacional sem clareza de causa individual;
- Há desistência de diálogo, afastamento ou abandono de processos terapêuticos;
- Há choque entre códigos psíquicos, culturais ou geracionais.

Essas situações não são falhas cognitivas nem necessariamente patologias. São, sobretudo, **problemas de tradução de sentidos**.

🔗 SISTEMA REDE 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

6. Origem Conceitual

O **Protocolo Ursula** emerge a partir da reflexão conjunta entre Paula Caroline e Ursula Paiva (psicóloga e psicanalista), em diálogo realizado em 07/01/2026. Nesse diálogo, evidencia-se a dificuldade prática de transformar saberes clínicos profundos — especialmente os ligados à psicanálise, cultura e subjetividade — em instrumentos operacionais acessíveis, éticos e de alcance ampliado.

A metáfora central apresentada por Ursula — a do *tradutor* — torna-se o eixo fundador do protocolo.

7. Definição do Protocolo Ursula

O **Protocolo Ursula** é definido como: um **Protocolo Autônomo de Mediação Psíquica e Social (PAMPS)**, voltado à tradução de sentidos entre sujeitos, respeitando diferenças simbólicas, culturais e posicionais, sem exercer função diagnóstica, terapêutica ou normativa.

8. Princípios Herdados (sem Dependência)

O **Protocolo Ursula herda princípios**, e não estruturas operacionais, dos agentes de inteligência artificial ‘Lucas’ e ‘Dra Nise’.

8.1 Princípios Inspirados em Lucas

- Organização lógica do pensamento;
- Estruturação clara de problemas complexos;
- Capacidade de transformar narrativas em documentos compreensíveis;
- Separação explícita entre contexto, problema e diretrizes possíveis.

8.2 Princípios Inspirados na Dra Nise

- Linguagem acolhedora e não patologizante;
- Respeito ao tempo psíquico dos envolvidos;
- Centralidade do humano antes da técnica;
- Escuta ampliada e contextualizada.

Esses princípios orientam o **modo de operar**, não os dados utilizados.

9. O que o Protocolo Ursula NÃO É

Para preservação ética e conceitual, define-se que o **Protocolo Ursula**:

- Não realiza diagnóstico clínico;
- Não substitui acompanhamento terapêutico;
- Não interpreta o inconsciente;
- Não prescreve condutas;
- Não se apresenta como tratamento;
- Não coleta nem depende de séries históricas extensas.

Sua função é **mediadora**, não interventiva.

10. Função Central: Mediação por Tradução

A função central do **Protocolo Ursula** é atuar como um **dispositivo de tradução de sentidos**. Essa tradução envolve:

- Converter mensagens para formas mais escutáveis pelo outro;
- Tornar explícitas diferenças de linguagem emocional e simbólica;
- Evidenciar ruídos comunicacionais sem atribuição de culpa;
- Apoiar a construção de mensagens possíveis, e não ideais.

O protocolo não busca revelar “o que a pessoa realmente quis dizer”, mas sim: **Como algo pode ser dito de forma que o outro consiga escutar.**

11. Dimensão Cultural

O **Protocolo Ursula** reconhece que sofrimento e regulação emocional são atravessados por contextos culturais.

Demandas sociais, normas implícitas, expectativas de desempenho e estilos de interação variam entre culturas, famílias e grupos sociais. O protocolo considera essas variáveis como **componentes do problema**, e não como ruídos a serem eliminados.

Assim, evita-se a patologização de reações que podem ser, na realidade, respostas a ambientes excessivamente demandantes.

12. Escopo de Aplicação

O **Protocolo Ursula** é aplicável, especialmente, em:

- Mediação familiar (pais, filhos, cuidadores);
- Apoio reflexivo a profissionais clínicos;
- Situações de conflito comunicacional persistente;
- Contextos de abandono e/ou ruptura de diálogo;
- Tradução de mensagens emocionalmente difíceis.

Não se destina a todos os problemas humanos, mas a **um tipo específico de impasse relacional**.

13. Autonomia do Protocolo

Neste estágio, o Protocolo Ursula é **intencionalmente autônomo**.

Ele não se integra operacionalmente ao Sistema REDE, embora dialogue conceitualmente com suas boas práticas. Essa autonomia garante:

- Clareza de escopo;
- Preservação ética;
- Facilidade de compreensão por profissionais não técnicos;
- Flexibilidade de uso em diferentes contextos.

Futuras integrações poderão ser consideradas apenas após validação conceitual e prática.

14. Considerações Finais

O **Protocolo Ursula** nasce para ocupar um espaço negligenciado por sistemas tradicionais: o espaço **entre pessoas**.

Ele não pretende resolver o sofrimento humano, mas **apoiar profissionais na redução do ruído que impede o encontro**, oferecendo mediações possíveis, éticas e respeitosas.

Ao fazer isso, preserva o saber clínico, respeita a cultura, protege o humano e amplia as possibilidades de cuidado.

Este documento apresenta, portanto, o **Protocolo Ursula** como um dispositivo legítimo de mediação psíquica e social, inspirado nas boas práticas do Sistema REDE - mas voltado às necessidades específicas apresentadas no contexto de evolução v2 para v3.

🔗 SISTEMA REDE 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

ANEXO A: APRESENTAÇÃO

O **Protocolo Ursula** nasce de uma inquietação clínica bastante comum: em muitos atendimentos, especialmente com adolescentes, famílias ou contextos atravessados por fortes assimetrias simbólicas, o que se observa não é ausência de palavra, mas dificuldade de escuta. Não exatamente falta de comunicação, mas desencontro entre modos de dizer, lugares subjetivos e expectativas que não se reconhecem.

O **Protocolo Ursula** não se apresenta como método terapêutico, nem como técnica clínica. Trata-se de um **dispositivo de mediação psíquica e social** pensado para operar no campo da comunicação — esse território tão familiar à clínica, onde algo se diz, mas não chega ao outro.

Como parte do protocolo, existe um **Questionário de Mediação Inicial**, concebido apenas como uma possibilidade de entrada quando o impasse comunicacional se torna central. Ele não organiza a fala em categorias clínicas, não busca clareza, coerência ou conclusão. Ele acolhe contradições, lacunas e repetições, oferecendo um primeiro contorno narrativo para aquilo que, muitas vezes, aparece de forma difusa ou excessivamente carregada de afeto.

O **Protocolo Ursula** preserva, de maneira rigorosa, os fundamentos da clínica psicanalítica: a singularidade do sujeito, o lugar do inconsciente, a centralidade da transferência e o valor do não-saber. Não propõe correção do discurso, nem tradução de verdades psíquicas.

Parte-se apenas da ideia de que, em certos momentos, antes que algo possa ser interpretado, talvez precise tornar-se **minimamente escutável** — sem que isso implique solução, acordo ou pacificação do conflito.

O protocolo é oferecido como uma proposta aberta, não normativa, para profissionais que desejem dispor de um recurso auxiliar de mediação, sem abrir mão da ética e da profundidade da clínica.

🔗 **SISTEMA REDE** 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

ANEXO B: QUESTIONÁRIO DE MEDIAÇÃO INICIAL (QMI) DO PROTOCOLO URSULA

Este instrumento não tem finalidade diagnóstica, interpretativa ou avaliativa. Seu uso deve respeitar o método e a ética da escuta psicanalítica. As respostas não visam produzir conclusões, mas **material simbólico** que auxilie a compreensão de impasses comunicacionais e relacionais.

1. O IMPASSE (O QUE NÃO CIRCULA)

1.1 Há algo que o(a) analisando(a) refere como difícil de dizer ou impossível de ser dito a alguém específico?
(Registrar conforme o discurso apresentado.)

1.2 A quem esse dizer se dirige, mesmo que de forma implícita?

1.3 Esse impasse aparece como recente ou como repetição de algo mais antigo?

2. A DEMANDA (O QUE SE BUSCA NO DIZER)

2.1 O que o(a) analisando(a) espera que o outro compreenda e/ou reconheça?

2.2 O que parece estar em jogo nessa tentativa de comunicação?
(Ex.: reconhecimento, amor, limite, reparação, separação.)

3. O MAL-ENTENDIDO (ONDE O SENTIDO SE DESLOCA)

3.1 Como o(a) analisando(a) descreve a reação do outro quando tenta se expressar?

3.2 Há recorrência de interpretações equivocadas, silêncios ou respostas defensivas?

3.3 Quais afetos emergem após essas tentativas frustradas de comunicação?

4. A POSIÇÃO DO OUTRO (NA FALA DO SUJEITO)

4.1 Como o outro é representado no discurso do(a) analisando(a)?
(Ex.: inacessível, autoritário, frágil, ausente, invasivo.)

4.2 O que o(a) analisando(a) supõe que o outro não consegue ouvir ou sustentar?

5. CONTEXTO SIMBÓLICO, FAMILIAR E CULTURAL

5.1 Esse impasse aparece ligado a lugares simbólicos específicos?
(Ex.: pai, mãe, autoridade, lei, expectativa social.)

5.2 Há marcas culturais, geracionais ou familiares que atravessam essa dificuldade de dizer?

6. TENTATIVAS DE CONTORNO

6.1 Que estratégias o(a) analisando(a) já utilizou para tentar se fazer escutar?
(Silêncio, escrita, explosão, retraimento, mediação por terceiros.)

6.2 Alguma dessas tentativas produziu deslocamento, ainda que momentâneo?

🔗 **SISTEMA REDE** 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

7. A MEDIAÇÃO COMO QUESTÃO (E NÃO SOLUÇÃO)

7.1 O(a) analisando(a) expressa desejo de ajuda para “traduzir”, “organizar” ou “preparar” uma fala?

7.2 Há resistência, receio ou ambivalência em relação a ser compreendido(a)?

8. REGISTRO LIVRE DO PROFISSIONAL

8.1 Observações clínicas relevantes sobre o lugar desse impasse na economia psíquica do sujeito.
(Campo livre — não obrigatório.)

Observação Ética e Clínica

Este questionário não propõe interpretação, condução da fala ou correção do discurso do analisando. Seu uso deve sempre preservar:

- a transferência;
- o método da associação livre;
- a singularidade do sujeito;
- o não-saber como operador clínico.

O Protocolo Ursula, neste contexto, funciona como **dispositivo auxiliar de leitura do mal-entendido**, e não como técnica psicanalítica.

🔗 SISTEMA REDE 🌐
PROTOCOLO URSULA (PAMPS)

ANEXO C: Síntese da Conversa entre Paula Caroline e Ursula Paiva

Data: 07/01/2026
Meio: WhatsApp

A conversa entre Paula Caroline e Ursula Paiva teve início a partir de reflexões sobre a possibilidade de utilização de tecnologias baseadas em inteligência artificial como apoio a práticas clínicas e familiares, especialmente no campo do autismo e das relações humanas.

Ursula Paiva, psicóloga e psicanalista, manifesta inicialmente não possuir conhecimento técnico em programação e/ou tecnologia, expressando também preocupações quanto aos limites éticos e conceituais de qualquer tentativa de sistematização excessiva do saber clínico.

Entre suas colocações, destaca-se o receio de que uma eventual modelagem tecnológica se limite à experiência individual de um profissional ou desconsidere a complexidade cultural envolvida nos processos psíquicos.

Ao longo do diálogo, Ursula enfatiza que o autismo e o sofrimento psíquico assumem sentidos distintos a depender do contexto cultural, das demandas sociais e das formas de organização das relações em diferentes sociedades.

Ressalta que ambientes com menor exigência de interação social podem favorecer maior regulação para algumas pessoas autistas, enquanto sociedades altamente demandantes podem intensificar sofrimento e desorganização emocional.

Paula Caroline apresenta, então, o funcionamento geral do Sistema REDE, descrevendo sua experiência prática no uso de relatórios técnicos e narrativos como apoio à organização familiar, à tomada de decisões

cotidianas e à mediação de situações complexas envolvendo seu primo Guilherme.

Explica que o sistema não se propõe a substituir o cuidado humano, mas a estruturar informações, gerar relatórios e apoiar processos de reflexão e planejamento.

Durante a conversa, Ursula compartilha um exemplo clínico marcante: o atendimento de uma adolescente que vivenciava intensa ansiedade ao tentar comunicar ao pai um conteúdo emocionalmente difícil.

Segundo Ursula, a dificuldade central não residia na ausência de linguagem ou de vínculo, mas na incapacidade mútua de compreensão entre pai e filha.

Nesse contexto, a psicanalista relata ter pensado em atuar como uma espécie de “tradutora”, auxiliando a adolescente a formular a mensagem de modo mais escutável pelo pai — analogia que se torna um eixo conceitual relevante do diálogo.

Ursula observa que, idealmente, seria desejável um dispositivo capaz de realizar uma mediação mais interativa e simultânea entre as partes, reconhecendo, contudo, limites técnicos e práticos para tal proposta em sua atuação clínica cotidiana.

Ela também menciona que a adolescente em questão acabou abandonando o tratamento, fato que amplia a reflexão sobre as consequências das falhas de comunicação e mediação nos vínculos terapêuticos e familiares.

Ao longo do diálogo, Paula Caroline propõe a possibilidade de construção de modelagens que não se limitem a dados técnicos ou diagnósticos, mas que aprendam vocabulários, contextos e formas singulares de expressão dos sujeitos envolvidos, sempre com regras claras de humanização, ética e respeito ao saber clínico.

Ressalta ainda que tais modelagens poderiam operar como dispositivos de apoio reflexivo, e não como substitutos da clínica.

A conversa encerra-se com a manifestação, por parte de Ursula Paiva, do desejo de contribuir com seus conhecimentos e experiências, ainda que reconhecendo seus limites técnicos, expressando abertura à transmissão e à transformação do saber clínico em novas formas de cuidado mediado.

Essa troca de ideias evidencia, de maneira clara, a existência de uma lacuna entre o saber clínico profundo, as demandas relacionais contemporâneas e os instrumentos disponíveis para mediação de conflitos comunicacionais, lacuna que fundamenta a criação do **Protocolo Ursula** como um dispositivo autônomo de mediação psíquica, cultural e comunicacional.